Doenças Transmitidas por Alimentos

Docente Me. Emy Hiura





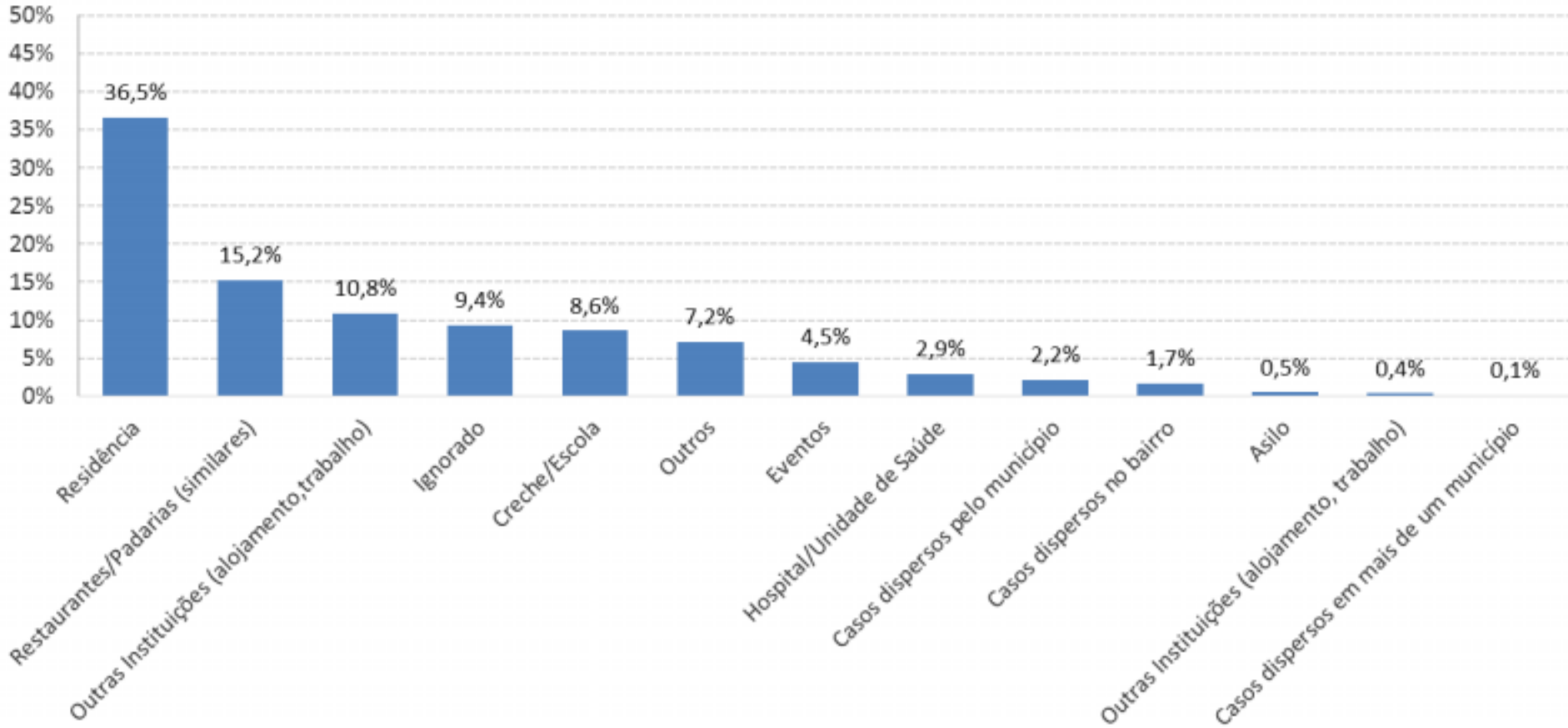
Introdução

- Grupo de doenças causadas pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados;
- Os sintomas digestivos não são as únicas manifestações desta síndrome;
- Além de variar quanto ao quadro clínico, podem ser causadas por toxinas produzidas pelas bactérias ou substâncias tóxicas, tais como metais pesados, assim como ação direta das bactérias, vírus e parasitas.

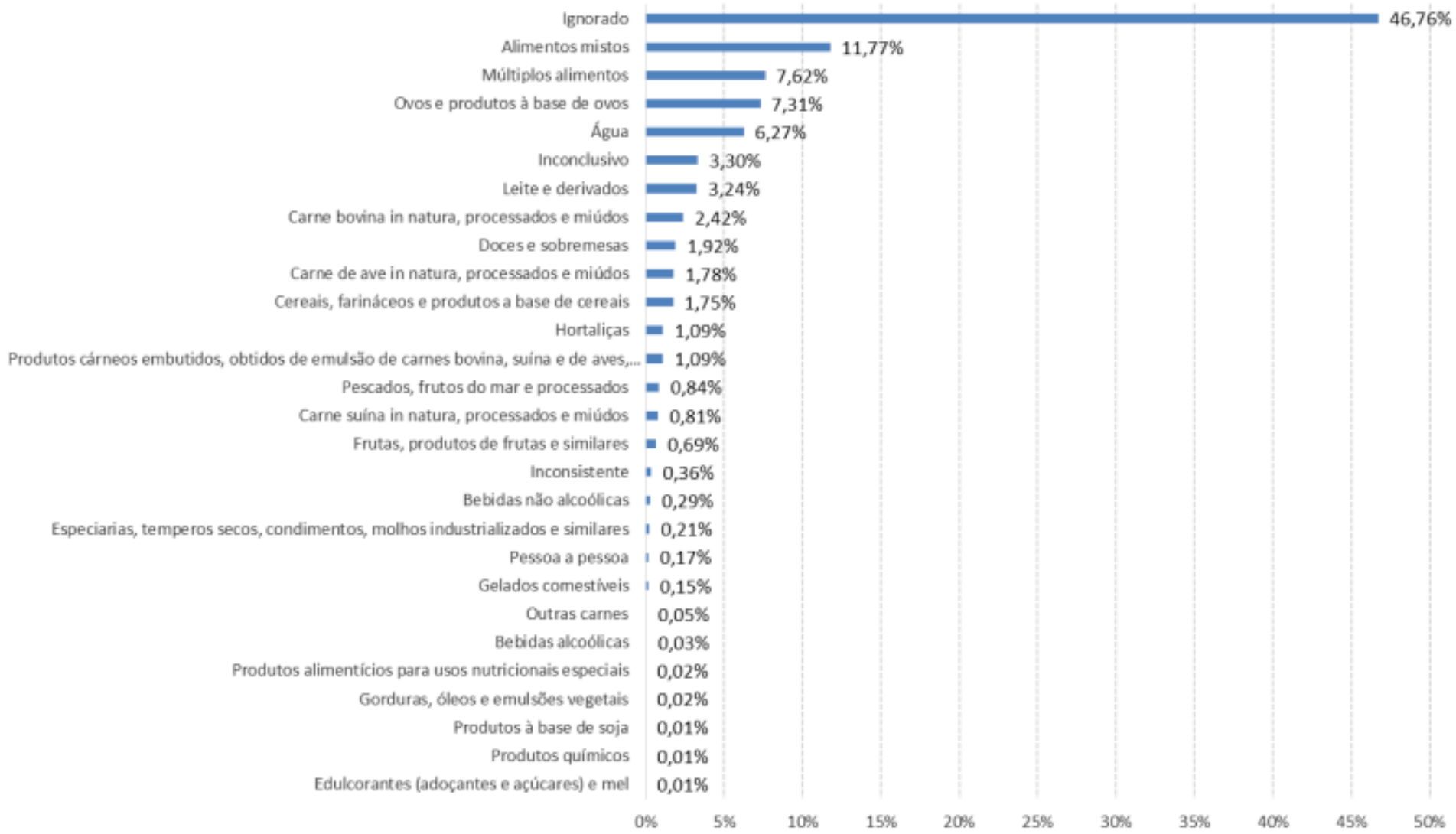
Série histórica de surtos de DTA. Brasil, 2000 a 2017*.

Ano de notificação	Surtos	Expostos	Doentes	Óbitos	Taxa de letalidade
2000	545	31.943	9.613	4	0,04%
2001	897	211.228	15.706	5	0,03%
2002	823	116.962	12.402	5	0,04%
2003	620	688.742	17.981	4	0,02%
2004	645	368.167	21.781	21	0,10%
2005	923	242.191	17.279	12	0,07%
2006	577	49.044	10.356	8	0,08%
2007	683	25.195	11.635	11	0,09%
2008	641	23.275	8.736	26	0,30%
2009	594	24.014	9.407	12	0,13%
2010	498	23.954	8.628	11	0,13%
2011	795	52.640	17.884	4	0,02%
2012	863	42.138	14.670	10	0,07%
2013	861	64.340	17.455	8	0,05%
2014	886	124.359	15.700	9	0,06%
2015	673	35.826	10.676	17	0,16%
2016	538	200.896	9.935	7	0,07%
2017*	557	46.524	9.065	9	0,09%
Total Geral	**12.619**	**2.371.438**	**238.909**	**183**	**0,08%**

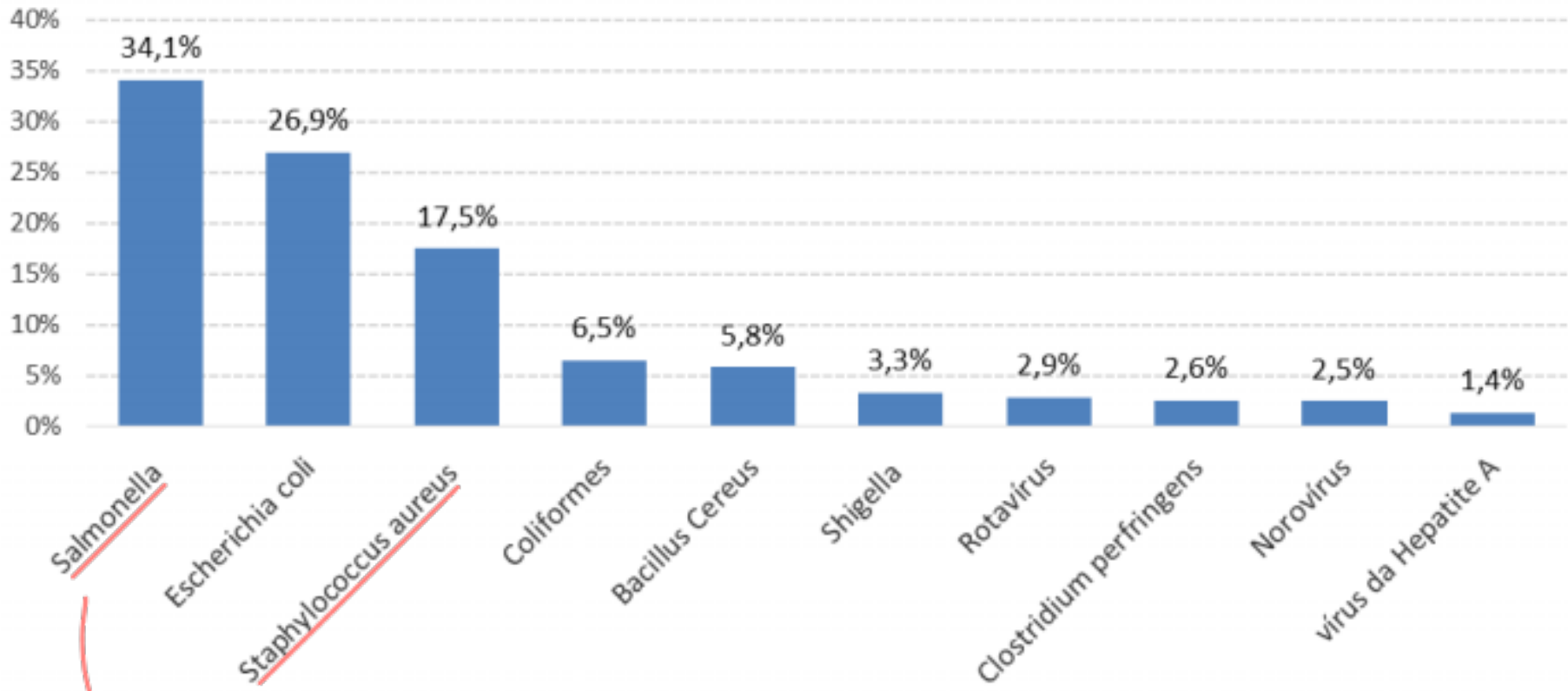
Distribuição dos surtos de DTA por local de ocorrência. Brasil, 2000 a 2017*.



Distribuição dos alimentos incriminados em surtos de DTA. Brasil, 2000 a 2017*.



Distribuição dos 10 agentes etiológicos mais identificados em surtos de DTA. Brasil, 2000 a 2017*.

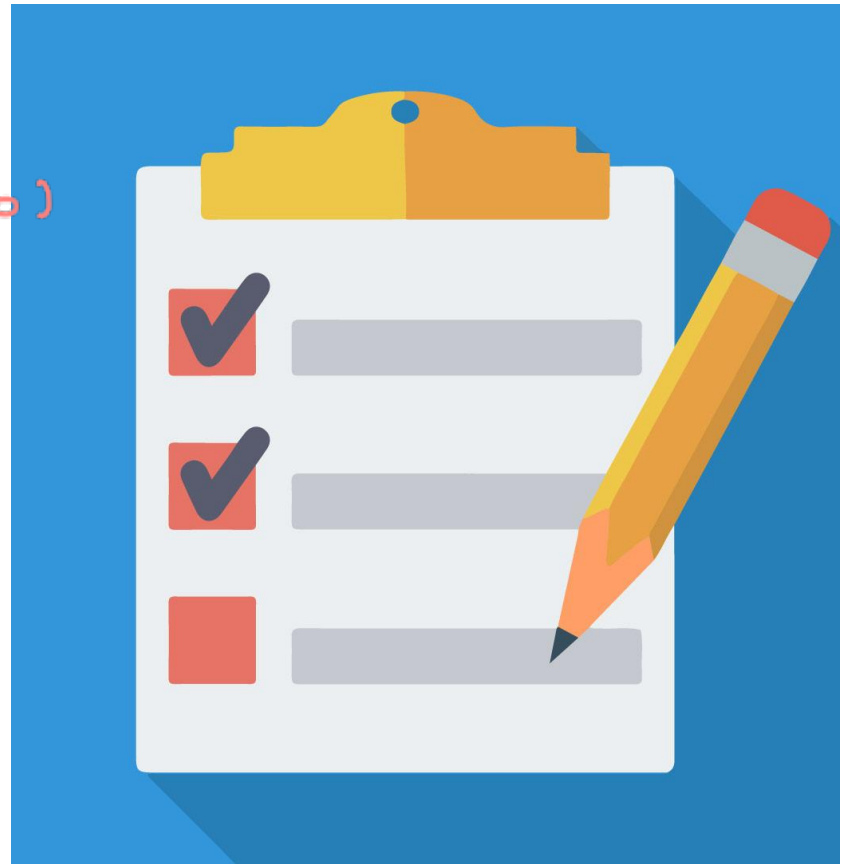


Fonte: Sinan/SVS/Ministério da Saúde
*Dados sujeitos a atualização

principais patógenos relacionados a intoxicação alimentar

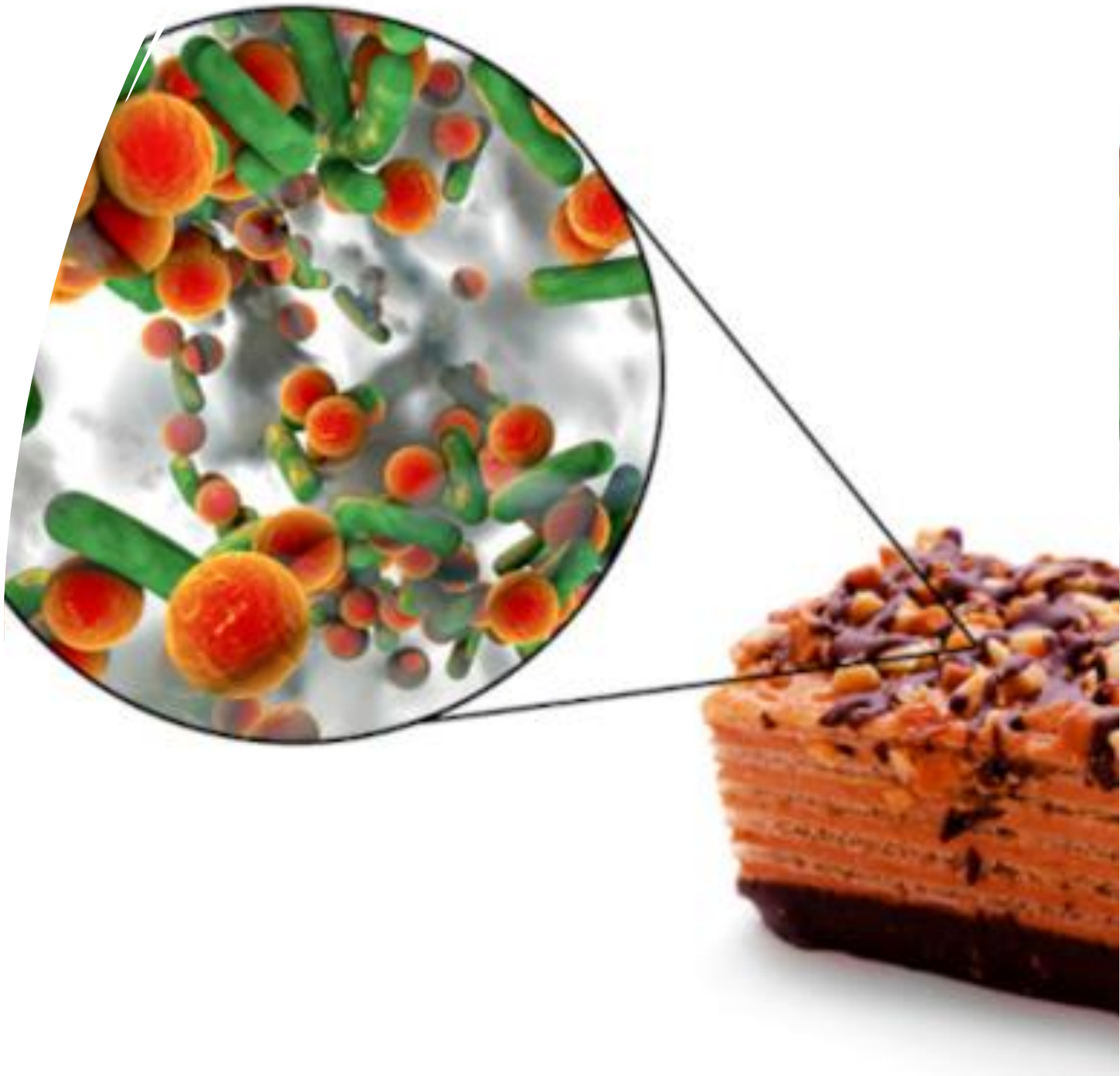
Fatores que contribuem para o aumento dos casos

- Crescimento de população
- Existência de grupos populacionais vulneráveis ou mais expostos (pacientes ♀ jovens ou ♀ idosos)
- Processo de urbanização desordenado e a necessidade de produção de alimentos em grande escala
- Deficiente controle dos órgãos públicos e privados em relação a qualidade dos alimentos ofertados às populações
- Consumo de alimentos em vias públicas
- Globalização e as facilidades atuais de deslocamento da população, inclusive no nível internacional



Aspectos gerais

- O período de incubação depende do agente etiológico, podendo variar de hora (botulismo) a meses (listeriose);
- A suscetibilidade é geral, com risco maior para certos grupos (crianças, idosos, imunodeprimidos),
- Os agentes infecciosos mais comuns são os de origem bacteriana;



Mecanismos Patogênicos Envolvidos na Determinação das DTA

- **Infecção alimentar** (agente microbiológico que invade o tecido causando alterações)

Salmonella spp, Shigella spp, Yersinia enterocolitica

- **Intoxicação alimentar** (há penetração do tecido pelo agente, que começa a se proliferar, liberando toxinas, já ingerido ou no momento da ingestão)

S. aureus, B. cereus (cepa emética) e *C. botulinum*

metais pesados, agrotóxicos, fungos silvestres, micotoxinas

- **Toxinfecção alimentar**

V. cholerae, V. parahaemolyticus, C. perfringens

(agente, provocado pela ingestão da toxina causa uma alt. proliferativa no alimento e nos intoxicamos a partir dele)

Mecanismos Envolvidos na Determinação da Fonte de Infecção

- Não basta que haja presença do agente infeccioso no alimento para que ocorra uma DTA – é preciso alguns fatores que favoreçam a proliferação do agente infeccioso, bem como a sua sobrevivência;

- Falta de higiene, temperaturas inadequadas (frio e calor), alimentos preparados em grandes quantidades,





Vigilância das DTAs

- Instância em saúde municipal;
- Vigilância Epidemiológica (ponto principal), Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Assistência à Saúde e Laboratório de Saúde Pública;
- IDAF/MAPA... Se necessário



- A **Vigilância Epidemiológica:** coordenar a investigação, realizar o inquérito, coletando dados dos comensais (doentes e não doentes), importantes para elucidar o surto.

- A **Vigilância Sanitária:** realizar inspeções sanitárias no estabelecimento produtor/fornecedor do alimento.

- A **Vigilância Ambiental:** coleta de amostras de água, bem como envio para o laboratório de referência.

- **Assistência à Saúde:** tratamento das pessoas doentes, bem como coleta de amostras clínicas, como sangue e fezes.

- **Laboratório de Saúde Pública:** análise dos materiais recebidos.

* as intoxicações alimentares vem sendo exponencialmente crescentes!



Obrigada!